

医療処置を実施している患者の避難方法①

＜中心静脈カテーテル、PICC、末梢点滴＞

- ① 避難時に輸液の高さを維持したまま独歩可能な場合、そのままの状況で避難する。
- ② 避難時に輸液の高さを維持できず歩行できない場合、クレンメを止めて、患者に抱きこませる、又は患者と共にシートにくるむようにして避難する。避難場所まで来て再開する時は、再開できる状況であるか確認してから再開する。

＜輸液ポンプ、シリンジポンプ＞

ポンプが外せるかどうかは、患者の状況、投与している薬剤で判断する。

- ① ポンプが外せる場合は、ポンプを外す。患者が独歩で避難できるときは、自然落下で調整する。患者が歩けない場合は、クレンメを止めて寝具などに巻き込んで避難する。
- ② ポンプが外せない場合、避難開始直前にクレンメをロックしてポンプをコンセントから抜き、ポンプごと寝具にくるみ避難する。避難完了までアラームは無視する。再開時は、ルートを確認し、閉塞アラーム解除の手順に従って（急速注入にならないように圧を抜いてから）開始する。

＜酸素、CPAP、ネーザルハイフロー＞

- ① 酸素ボンベを準備する。
- ② パルスオキシメーターを患者に装着する（患者に対して数が不足している場合は、患者の状況により優先順位を判断し、適宜測定する）。
- ③ 中央配管から酸素ボンベに、手順に従ってつなぎ代える。
- ④ 部署全体の酸素吸入患者を繋ぎ代えたら、部署のシャットオフバルブを閉鎖する。

医療処置を実施している患者の避難方法②

人工呼吸器	最低でも 3 人を確保(可能なら一人は医師)。医師が確保できない時は、医師に人工呼吸器患者の避難準備を報告し、酸素量などの指示を仰ぐ。 1人はアンビューバックを押し、2人は移送を行う。安全確保のため最後に避難する。人員が確保できない場合は、できるだけ安全と思われるところでアンビューバックを押しながら助けを待つ。 ① 酸素ボンベ、アンビューバックを準備する。 ② パルスオキシメーターを患者に装着する。 ③ 人工呼吸器を外し、アンビューバックを装着。アンビューバックを押しながらエアーストレッチャーなどで移動する。
胸腔ドレーン	＊移動時ドレーンのクランプは不要＊ ① メラサキウムをコンセントから外す。 ② 独歩で避難ができる場合 メラサキウムをスタンドから外し持たせて避難させる。 ③ 歩けない場合 メラサキウムをスタンドから外し患者と共に避難する。
各種ドレーン 経鼻胃管 イレウスチューブ SB バック マルチチャネル PTCD チューブ等	＊移動時ドレーンのクランプは不要＊ ① 歩行できる場合 排液ボトルまたは排液バッグを患者に持たせて避難させる。 ② 歩行できない場合 排液ボトル又は排液バックを患者と一緒にシートでくるみ避難する。
直達牽引	① 下肢の場合 馬蹄型からロープを外す。 架台から静かに患肢を下ろし、馬蹄の下にタオルをあてて包帯又は絆創膏で患肢に固定する。 患者の身体をシートで馬蹄ごと包む。 ② 上肢の場合 馬蹄型又は翼状ピンからロープを外す。 患肢を静かに下ろして体幹に包帯又は三角巾、絆創膏で固定する。